SDD 167 Sujet n°1

Spécialité : Médecine générale

Date : 03/04/2024
Auteur : Valentin BRARD (DES médecine générale)
Relecteur(s) : Clément FILLIOL (DES RAI), Sébastien VILLARD (DES MIIC)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item(s) en lien avec la station	154 - Infections broncho pulmonaires de l'adulte 203 - Dyspnée aiguë et chronique 204 - Toux chez l'adulte
Situation(s) de départ en lien avec la station	167 - Toux 162 - Dyspnée
Matériel nécessaire à la station	- Annexe n°1 - IPAD pour examinateur - Feuille de brouillon pour candidat - Stylo pour candidat - Feuille de brouillon pour évaluateur - Stylo pour évaluateur
Contexte de la station	Cabinet de médecine de ville

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes un·e médecin généraliste en cabinet médical, en période hivernale.
Vous recevez monsieur Liston, âgé de 53 ans, qui présente une toux grasse depuis 7 jours et se dit essoufflé au bout d'une centaine de mètres en terrain plat.

Monsieur Liston est chauffeur de taxi, pèse 80 kg pour 1m70 (IMC 27.7) et a pour antécédents une hypertension artérielle équilibrée sous énalapril (IEC) et hydrochlorothiazide (diurétique thiazidique) et un diabète mal équilibré (dernière HbA1c 9%) non compliqué avec majoration récente de son traitement par metformine et ajout d'une sitagliptine.

Constantes ce jour : T°39.2, FC 106, Sat 97%, FR 24, TA 150/90.
Le patient est conscient et orienté dans le temps et l'espace.
Votre examen physique révèle un syndrome de condensation alvéolaire à l'hémi-champ pulmonaire droit (diminution du murmure vésiculaire et présence de râles crépitants).
Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite ni gauche.

Vous suspectez donc une pneumopathie aiguë communautaire.

Consignes :

Vous devez, après avoir pris connaissance du contexte, en 7 minutes :

- Décrire et justifier la suite de votre prise en charge
- Prescrire d'éventuel(s) examen(s) complémentaire(s) et le (les) analyser à voix haute le cas échéant
- Formuler à voix haute une proposition de traitement

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique
- Réaliser de geste technique

Attention : Vous avez 8 minutes à compter du premier signal sonore, incluant la lecture des consignes. Au signal suivant sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (11 points)			
Stratégie de prise en charge (7 points)			
1.	Indique une prise en charge ambulatoire	1 pt	☐
2.	Justifie l'orientation ambulatoire par l'absence de critère au score CRB 65 (**doit tous les citer**) - Le patient n'est pas confus - FR < 30 - PAS > 90 PAD > 60 - Âge < 65 ans	1 pt	☐
2.	Prescrit une radiographie thoracique de face	1 pt	☐
3.	Recherche une allergie aux pénicillines	1 pt	☐
4.	Antibiothérapie probabiliste du sujet comorbide → Annonce la nécessité d'un traitement par amoxicilline-acide clavulanique PO	1 pt	☐
5.	Prescrit l'antibiothérapie pour 7 jours	1 pt	☐
6.	Propose un traitement symptomatique (paracétamol si besoin) associé à l'antibiothérapie	1 pt	☐
7.	Annonce la réalisation d'un rendez-vous de contrôle à 48-72 heures	1 pt	☐
Iconographie (3 points)			
9.	Précise qu'il s'agit d'un examen de bonne qualité	1 pt	☐
10.	Identifie l'anomalie : condensation du lobe moyen (disparition du bord droit de la silhouette cardiaque)	1 pt	☐
11.	Précise l'absence d'autre anomalie sur l'imagerie	1 pt	☐
Communications et attitudes (3 points)			

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	/ 13 points

Éléments de rétroaction :

Score d'orientation du patient : CRB 65

Remarques concernant le traitement :

- Fluoroquinolones réservées aux situations de résistance au pneumocoque
- Traitements injectables (C3G) plus douloureux (IM) et moins pratiques en ville (IV : passage d'IDE au domicile tous les jours)
- Pristinamycine : réservée aux allergies à la pénicilline

Penser à cette consultation de contrôle à 48-72h +++

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le ou la candidat·e est médecin généraliste en cabinet.

Plan de la station ECOS :

Le patient est face au candidat. Un bureau sépare les deux participants.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bonjour docteur,
Je viens vous voir parce que je tousse et je me sens essoufflé depuis une semaine."

Identité du patient :

Homme, LISTON Robert, 53 ans, 1m80, 80kg

Mode de vie :

Chauffeur de taxi, célibataire, pas de tabac, alcool occasionnel (2 fois par semaine, 3 verres à chaque fois), **pas d'allergie**.

Comportement global :

Coopérant et sympathique. Un peu fatigué par la fièvre, sans altération majeure de l'état général.

Antécédents personnels :

- Surpoids (80 kg pour 1m70 soit un IMC à 27.7)
- Diabète non compliqué, non équilibré
- hypertension artérielle contrôlée

Antécédents familiaux :

Le patient a coupé les ponts avec ses parents il y a longtemps. Il ne rapporte pas d'antécédents familiaux.

Médicaments :

- Metformine 1000 mg trois fois par jour
- Sitagliptine 100 mg une fois par jour
- Enalapril-hydrochlorothiazide 20mg/12.5mg une fois par jour

Symptômes positifs :

- Toux
- Fièvre 39.2 °C
- Dyspnée mMRC2 (essoufflé quand il marche à son pas habituel, à plat)

NB : L'examen clinique est déjà réalisé et donné dans l'énoncé. L'étudiant·e ne doit pas le compléter.

Symptômes négatifs :

- PAS DE DOULEUR THORACIQUE
- PAS DE SIBILANT
- PAS D'ORTHOPNÉE (la dyspnée n'augmente pas en position allongée)
- PAS DE VARIATION POSITIONNELLE DE LA TOUX

NB : L'examen clinique est déjà réalisé et donné dans l'énoncé. L'étudiant·e ne doit pas le compléter.

Constantes :

T°39.2, FC 106, Sat 97%, FR 24, TA 150/90

Donnée complémentaire :

Annexe n°1 : radiographie pulmonaire de face

- A remettre à l'étudiant une fois qu'il l'a annoncé nécessaire au patient.
- Si l'étudiant affirme qu'aucun examen complémentaire est nécessaire, lui donner l'annexe n°1 en lui disant "un examen complémentaire a finalement été prescrit au patient et réalisé en ville."

Questions de relance :

- Si l'étudiant·e n'a pas annoncé la nécessité d'une radiographie, **le patient témoin** dit "Faut-il faire des bilans pour explorer ce que j'ai ?"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

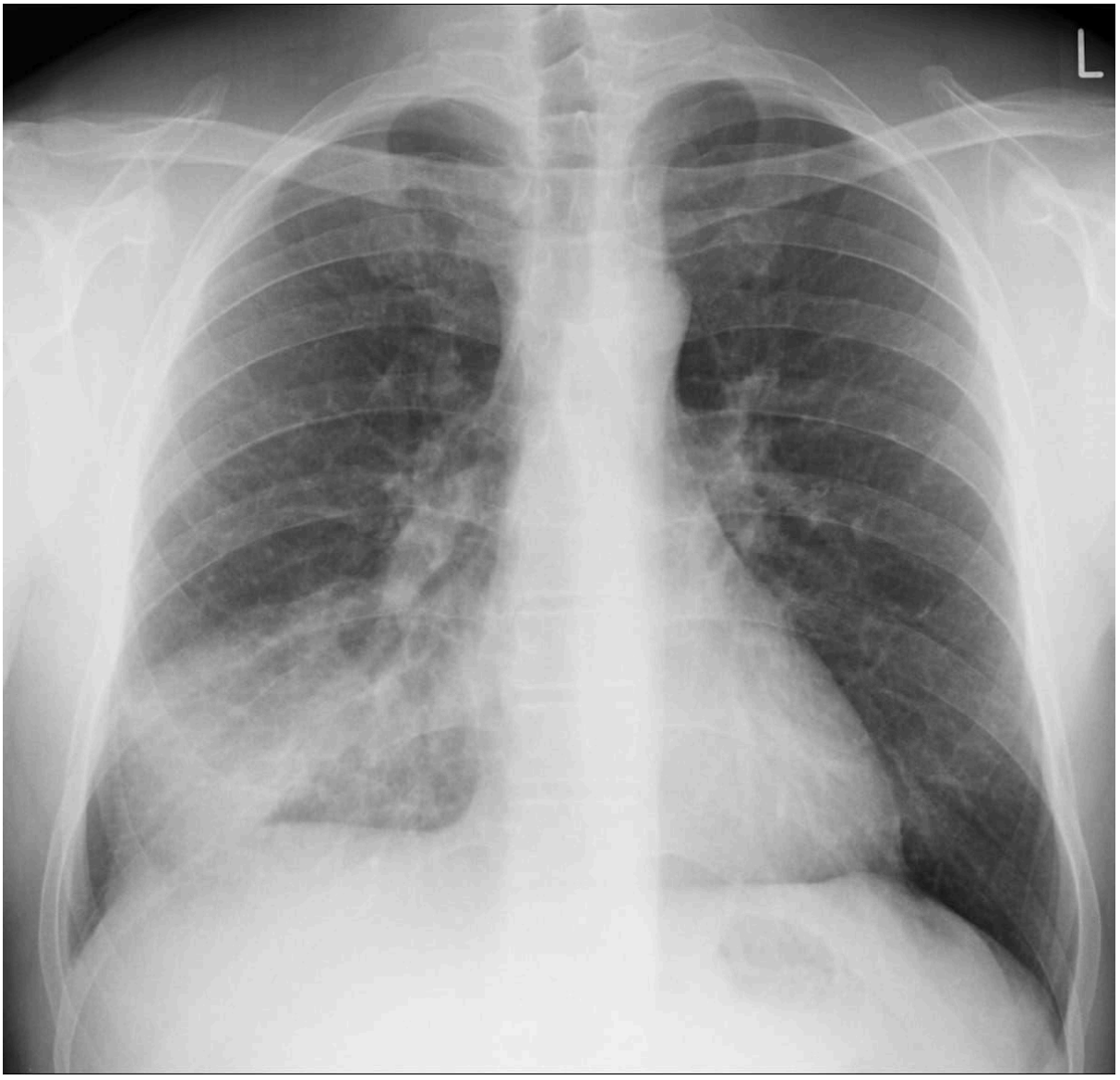
Plan de la station ECOS :

Le patient est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.
L'annexe n°1 n'est pas remise à l'étudiant·e dès le début de l'épreuve.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Annexe n°1

ANNEXE 1